Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«01» апреля 2022 № 99/22

Порядок организации работы в очагах
туберкулезной инфекции в ГБУЗ МО «МОКПТД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон №77 РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 6 июня 2001 года, Федеральный закон №52 РФ «О санитарном благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2003 г. N 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»; Приказа Минздрава РФ от 13.03.2019 N 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок организации работы в очагах туберкулезной инфекции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, согласно Приложениям:
1.1. Порядок регистрации очага туберкулезной инфекции (Приложение 1);
1.2. Алгоритм первичного выхода в очаг туберкулезной инфекции (Приложение 2)
1.3. Алгоритм первичного выхода в производственный очаг туберкулезной инфекции (Приложение 3);
1.4. Алгоритм обследования и наблюдения территориального очага туберкулезной инфекции (Приложение 4);
1.5. Алгоритм наблюдения за бытовым очагом (Приложение 5);
1.6. Журнал учета проведения заключительных дезинфекций в очагах (Приложение 6);
1.7. Журнал передачи сведений о проживающих в очаге туберкулезной инфекции (взрослые и дети) (Приложение 7);

1.8. Акт выхода в производственный очаг врача фтизиатра (Приложение 8);

1.9. Памятка больному и родственникам по проведению текущей дезинфекции в очаге (Приложение 9);

1.10. Журнал учета дезинфицирующих средств, выданных для проведения текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции». (Приложение 10);

1.11. Журнал регистрации территориальных очагов туберкулезной инфекции (Приложение 11);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях Шешелякину Н.Н.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Порядок регистрации очага туберкулезной инфекции

1. Место пребывания больного туберкулезом человека устанавливается на этапе регистратуры, на лицевую сторону медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), выносится:

1.1. Адрес постоянной регистрации пациента;
1.2. Адрес фактического места жительства;
1.3. Место работы (название организации), должность;
1.4. Адрес места работы.

2. В кабинете врача при сборе анамнеза, врач уточняет адрес фактического проживания пациента, с кем пациент проживает по данному адресу (члены семьи, родственники), записывает ФИО, дату рождения контактных лиц, уточняет контактные данные близких друзей, знакомых, имеются ли в очаге дети, есть ли у больного другие адреса проживания. Врач уточняет место работы пациента, его должность, место нахождения организации, имеется ли дополнительное место работы, также должность и место ее нахождения.

3. После подтверждения диагноза «туберкулез» решением ВК и постановки пациента на диспансерный учет, в территориальное отделение Роспотребнадзора отправляются учетная форма N 089/у-00 и форма 058/у "Экстренное извещение".

4. По согласованию с отделом госпитализации пациент направляется на стационарное лечение. Пациент с наличием бактериовыделения госпитализируется в стационар в течении суток (24 часов) с момента установления диагноза.

5. При оформлении медицинской документации для госпитализации бактериовыделителя, врач-фтизиатр участковый заполняет форму «Заявка на проведение заключительной дезинфекции в эпидемических очагах туберкулезной инфекции на дому на территории Московской области», получает номер наряда на проведение дезинфекции согласно номеру порядковой записи в журнале учета проведения дезинфекций, оправляет скан в ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» по электронной почте, в соответствии с адресом очага и копию в организационно-методический отдел ГБУЗ МО «МОКПТД» - по электронной почте: zelenovsn@mokptd.ru

6. Проведение заключительной дезинфекции планируется сразу после госпитализации больного, его выбытия из очага или после смерти пациента.

7. **При наличии в квартире детей,** сведения о их количестве, ФИО, возраст, место учебы и т.д. передаются в детские отделения врачам-фтизиатрам педиатрам по средством соответствующей записи **в** «Журнал передачи сведений о детях контактных с больными туберкулезом» (Приложение №7). Запись в журнал вносит **у**частковая медсестра взрослого отделения в течение суток после постановки на ДУ взрослого больного туберкулезом.

Далее, все сведения о изменения диагноза, обнаружения МБТ, выявления устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам у взрослого пациента, передаются врачом взрослого отделения в детское отделение в течении суток!

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Алгоритм первичного выхода в очаг туберкулезной инфекции

1. **Первичный выход в бытовой очаг туберкулезной инфекции** осуществляет врач-фтизиатр участковый, участковая медицинская сестра (при наличии детей в очаге фтизиопедиатр и участковая медицинская сестра детского кабинета) в течение 3 дней с момента постановки на учет больного туберкулезом.
2. При первичном выходе в бытовой очаг туберкулезной инфекции врач-фтизиатр участковый собирает и уточняет следующие сведения:
2.1. Проживает ли по данному адресу пациент;
2.2. Какой дом (кирпичный, панельный, монолит, деревянный);
2.3. Частный дом, многоквартирный;
2.4. Этажность дома, сколько в доме подъездов;
2.5. В каком подъезде, на каком этаже проживает пациент;
2.6. Имеется ли лифт;
2.7. Сколько на площадке квартир;
2.8. Общая площадь квартиры, площадь всех жилых комнат и мест общего пользования (кухня, туалет, коридор);
2.9. Какую комнату занимает больной (площадь), кто еще проживает с ним в одной комнате;
2.10. Наличие в квартире коммуникаций (свет, газ, вода, канализация)
- состояние квартиры светлая, темная, влажность, требуется ли ремонт (капитальный, косметический);
2.11. Санитарное состояние квартиры, наличие дез.средств, кто осуществляет уборку в доме;
2.12. Сколько человек проживает в квартире, кем они приходятся пациенту: родственники, соседи по коммунальной квартире;
2.13. Имеются ли дети, какую комнату они занимают;
2.14. Где и как хранятся личные вещи и посуда пациента;
2.15. Как и кем обрабатывается посуда больного, плевательница, личная одежда;
2.16. Соблюдает ли пациент правила поведения бациллярного больного (сан. эпид режим).
3. Врач и медсестра проводят инструктаж пациента и его родственников по обработке квартиры, посуды, личных вещей пациента, плевательницы.
4. Врач и мед сестра приглашают на обследование всех проживающих в квартире жильцов на обследование лично или через участкового врача терапевта.
5. На основании данных, полученных при опросе пациента, первичном посещении очага, врач-фтизиатр участковый устанавливает группу эпидемиологической опасности, разрабатывает план наблюдения и оздоровления очага.
Данные вносит в:

- форму 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях";
- «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза» (Приложение 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»);
- «Карту участковой медсестры» (учетная форма № 83 утвержденная МЗ СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об утверждении первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»;
- форма №30 (Приложение 1 утвержденное приказом МЗ СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об утверждении первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»).

6. Врач фтизиатр- педиатр посещает очаг, созданный взрослым больным, в котором проживают дети с кратностью согласно стандартам приказа №109, запись вносится в «Карте эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза» (Приложение 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»).

7. Все контактные лица из бытового очага должны быть обследованы в течении 14 -ти дней от даты постановки на учет больного туберкулезом.

8. При обследовании контактных лиц проводят следующие исследования:
- рентгенография ОГК. **Допускается проведение ФГР в другом учреждении. В этом случае контактное лицо должен предоставить результат ФГР и снимок.**

8.1. ДСТ;

8.2. При положительном или сомнительном ДСТ и наличии жалоб характерных для туберкулеза проводится КТ ОГК;

8.3. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ;

8.4. При наличии жалоб, положительном ДСТ – исследование мокроты, мочи на МБТ методами люминесцентной микроскопии, ПЦР, ВАСТЕС, ППС.

9. Лицам, находящихся в контакте с заразными формами туберкулеза (МБТ (+)) и лицам, имеющим положительный или сомнительный результат ДСТ по решению врачебной подкомиссии отделения филиала, назначается профилактическое лечение. Лечение проводится при согласии на него контактного лица.

10. Все контактные лица подлежат постановке на диспансерный учет в IV ГДН.

При обследовании и постановке на учет в амбулаторно-поликлиническом отделении, на контактных лиц, оформляется следующая медицинская документация:
- форма 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях";
- форма №30 Приложение 1 утвержденное приказом МЗ СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об утверждении первичной медицинской документации учреждений здравоохранения». «Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений».

11. В случае, если контактные лица своевременно не являются на обследование или уклоняются от его проведения, врач и медицинская сестра вызывают их по телефону и при повторном посещении очага. Сведения о вызовах на прием вносятся

в форму 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" врачом.

12. Сроки наблюдения контактных лиц определяются согласно приказам Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза и признании утратившими силу пунктов 16 - 17 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н» и приказа МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»). В дальнейшем, контактные лица с больным туберкулезом проходят обследование 1 раз в 6 месяцев.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Алгоритм первичный выхода в производственный очаг туберкулезной инфекции

1. Врач-фтизиатр уточняет наименование организации, место ее фактического нахождения, почтовый, электронный адрес, телефон, последний рабочий день (дата).

2. Врач направляет руководителю учреждения письмо о выявлении на предприятии случая заболевания сотрудника заразной формой туберкулеза с просьбой о назначении ответственного лица за организацию проведения противоэпидемических мероприятий в производственном очаге.

3. Врач договаривается с ответственным лицом о дате выхода в очаг, о датах обследования контактных.

4. В случае, если пациент относится к декретированному контингенту или руководитель уклоняется от проведения противоэпидемических мероприятий, к работе в очаге привлекаются сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора.

5. Выход в производственный очаг в учреждение, в котором работает или проходит обучение пациент, осуществляется врачом фтизиатром в течение 3 суток после постановки пациента на диспансерный учет.

6. Во время первичного выхода в производственный очаг врач-фтизиатр участковый определяет:

6.1. Где находится рабочее место пациента, его площадь;

6.2. Должность пациента;

6.3. Круг контактных (сколько человек постоянно находились в одном с ним помещении, периодические контакты). Определение мест общего пользования и площадь этих помещений;

6.4. Где пациент принимал пищу (общая столовая, комната для приема пищи, в своем кабинете). Наличие туалета, душа, общий коридор;

6.5. Имеется ли приказ о назначении ответственного лица за проведение медосмотров. Проводится ли плановый медосмотр, периодичность проведения медосмотров в данном учреждении. Наличие медосмотров при приеме сотрудников на работу. Сколько сотрудников прошли флюорографическое обследование в текущем году. Сколько сотрудников не прошли флюорографическое обследование в установленные сроки. Дата последнего флюорографического обследования выявленного пациента, его результаты, необходимо запросить снимок на пересмотр на предмет пропуска патологии;

6.6. Имеются ли у работников личные медицинские книжки или санитарные паспорта (Приказ от 20 мая 2005 года N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Письмо № 1100/2196-0-117 от 07.08.2000 МЗ РФ «О направлении перечня профессий»).

7. В результате проведенного эпидемиологического расследования врач фтизиатр заполняет «Акт выхода врача-фтизиатра в производственный очаг» (Приложение №6), в котором отражает четкий план работы, сроки его выполнения. Акт должен быть подписан руководителем учреждения, в котором работает пациент и заверен печатью учреждения.
8. Создается «Папка наблюдения за производственным очагом». В папке хранятся следующие документы:
8.1. «Акт выхода врача-фтизиатра в производственный очаг»;
8.2. Акт о проведенной заключительной дезинфекции в производственном очаге;
8.3. Списки контактных и списки с результатами обследования (в случае, если не оформлялись формы 025/у);
8.4. Предписание Роспотребнадзора о проведении противоэпидемических мероприятий в производственном очаге (в случае, если он привлекался к работе);
8.5. Все письма уведомления об обследовании очага с исходящими номерами.
8.6. Контактные лица из производственного очага проходят обследование в противотуберкулезном диспансере, в объеме:
8.6.1. Рентгенография ОГК;
8.6.2. Проводится ДСТ. При положительном или сомнительном ДСТ и наличии жалоб характерных для туберкулеза проводится КТ ОГК;
8.6.3. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ в случае назначения профилактического лечения.
9. Все контактные лица из производственного очага подлежат постановке на ДУ в IV ГДН и должны быть обследованы в течение 14 -ти дней от даты постановки на учет больного туберкулезом.
10. Лицам, находящихся в контакте с заразными формами туберкулеза (МБТ(+)) и лицам имеющим положительный или сомнительный результат ДСТ, по решению врачебной подкомиссии отделения филиала назначается профилактическое лечение. Лечение проводится при согласии на него контактного лица.
Обследование контактных из производственного очага 1 раз в 6 мес.
Срок наблюдения – 1 год.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Алгоритм обследования и наблюдения территориального очага туберкулезной инфекции

1. В течение 3-х дней после постановки на учет пациента, врач отправляет письмо на имя руководителей взрослой и детской поликлиник о необходимости проведения обследования контактных (взрослых и детей) в территориальном очаге. Один экземпляр письма остается в поликлинике, на втором экземпляре свою подпись ставит ответственный за работу по раннему выявлению туберкулеза в поликлинике, данный экземпляр вклеивается в форму 025/у или вкладываем в карту эпидобследования очага. В случае, если письмо отправлено электронной почтой, скриншот экрана монитора с изображением отправленного письма вместе с оригиналом письма вклеивается в форму 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" больного туберкулезом.
2. Представленные из поликлиник списки территориальных контактов с указанием даты флюорографического обследования, хранятся в «Карте эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза».
3. Сведения о **количестве** обследованных контактных из территориального очага вносятся в «Карту эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза» Приложение №2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», в таблицу «Другие лица, подлежащие наблюдению».
4. В случае, если производственный или бытовой очаг находится на территории другого муниципального образования (города, области), письма с просьбой о проведении противоэпидемических мероприятий направляются руководителю противотуберкулезной службы данной территории. В случае отсутствия ответа на запрос в течении 30 дней, повторно отправляется письмо, с просьбой провести противоэпидемиологические мероприятия и дать письменный ответ о проведенных мероприятиях.
5. При поступлении обращения в адрес отделений филиалов от руководителей других муниципальных образований с просьбой о проведении противоэпидемических мероприятий в очагах, находящихся на территории обслуживания филиала, обследование очага проводится в полном объеме в установленные законодательством сроки. По выполнению противоэпидемиологических мероприятий в очаге, врач оформляет и отправляет отчет о проделанной работе, в учреждение направившее запрос.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТНЫХ ЛИЦ НА ОДНОГО ВПЕРВЫЕ ВЫВЛЕННОГО БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ-
НЕ МЕНЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК!!!

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Алгоритм наблюдения за бытовым очагом

1. Повторные выходы в бытовой очаг осуществляют участковый врач-фтизиатр и участковая медицинская сестра взрослого отделения, при наличии в очаге детей – врач фтизиатр участковый и участковая медицинская сестра детского отделения, с кратностью согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в зависимости от группы эпидемиологической опасности. Кратность обследования очагов туберкулеза специалистами медицинской организации по профилю "фтизиатрия" (отделений, кабинетов) совместно со специалистами-эпидемиологами при динамическом наблюдении составляет:
для очагов 1 группы - 4 раза в год;
для очагов 2 группы - 2 раза в год;
для очагов 3 группы - 1 раз в год;
для очагов 4 и 5 групп – по мере необходимости.
2. При повторном посещении очага врач и медицинская сестра проверяют:
2.1. Наличие пациента по адресу очага;
2.2. Перепроверяет наличие контактных в очаге и их численность;
2.3. Соблюдение санитарно-гигиенических правил пациентом;
2.4. Имеются ли в наличии средства для проведения дезинфекции.
3. Врач осматривает пациента, проводит опрос на наличие жалоб и объективный осмотр контактных лиц. Медицинская сестра проводит беседу с пациентом и лицами, проживающими в очаге по вопросам проведения текущей дезинфекции, соблюдению санитарных норм и правил. При необходимости, приглашает контактных лиц на очередное обследование.
4. Полученные данные вносятся в форму 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" и «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза» Приложение 2 приказа МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», «Карту участковой медсестры» учетная форма № 085/у, ежемесячный отчет «Выходы в очаги туберкулёза».
5. В период нахождения пациента в стационаре, выходы в очаг осуществляются по плану. Цель выхода: проверка места нахождения пациента, наличие не известных контактных, если в очаге остаются контактные – наблюдение за ними.
6. Медицинская сестра выдает пациенту или члену семьи, осуществляющему проведение текущей дезинфекции в очаге I и II эпидемиологической значимости, дезинфицирующее средство и памятку по применению дезсредства с инструкцией.

7. Сведения о выданном средстве вносятся в «Журнал учета дезинфицирующих средств, выданных для проведения текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции». (Приложение 10) Так же сведения о выданном дезсредстве вносятся в форму 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" и «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза» Приложение 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», «Карту участковой медсестры» учетная форма 085/у.

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

ЖУРНАЛ
учета проведения заключительной дезинфекции в очагах
ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Филиал « »

Отделение _____

Начат с «____»_____ 20____г.

Окончен «____»_____ 20____г.

№ п /п	Ф.И.О и дата рождения(полностью) больного	Адрес проживания больного	Диагноз	Госпитализация состоялась в учреждение и дата госпитализации	Тип, площадь помещения	Дата подачи заявки	Дата проведения заключительной дезинфекции	Подпись ответственного лица

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

«Журнал передачи сведений о проживающих в очаге туберкулезной инфекции (взрослые и дети)»

№п/п	Дата	ФИО больного		Диагноз; МБТ (+) МБТ (-)	Адрес	Телефон	Родственные отношения	Кто передал	Кто принял
		Дети	Взрослые						

Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Акт выхода врача –фтизиатра в производственный очаг

Учреждение_____

Дата выхода в очаг (не позднее 3 дней после взятия эпидномера, установки диагноза)_____

Дата взятия на диспансерный учет или дата эпидномера_____

Выход в очаг по случаю заболевания туберкулезом (профессия)_____

_____

Краткое описание развития заболевания:

Проводилось ли флюорографическое обследование пациента при приеме на работу да/нет, дата ФГР _____ Результат_____

_____

Наименование организации, в которой пациент проходил ФГР _____

_____

Проходил ли пациент плановые профилактические осмотры да/нет, дата ФГР _____ Результат ФГР_____

Когда пациент был направлен к фтизиатру_____

_____

_____

Описание очага

В каком помещении находится рабочее место пациента (кабинет, цех и тд., его площадь _____

Место где принимал пищу пациент (столовая, кабинет и тд), площадь_____

_____

Места общего пользования (туалет, душ, раздевалка, коридор)_____

_____

Другие помещения, которые посещал пациент _____

_____

Численность сотрудников в очаге (с учетом последних 6 месяцев до выявления туберкулеза)_____

Охват профилактическими осмотрами сотрудников, находящихся в очаге:

Флюорографическое обследование сотрудников даты, % охвата _____

_____

_____

_____

Флюорография сотрудников:

Ответственное лицо за проведение профилактических осмотров у сотрудников:

_____

_____

Место проведения профилактических осмотров _____

_____

Количество сотрудников (списочный состав работающих сверить с табелем на зарплату) _____, прошли флюорографию с кратностью 1 раз в год с отметкой результата в санитарной книжке _____

Число сотрудников, не прошедших флюорографию в установленные сроки (ФИО, дата рождения, профессия, занимаемая должность) _____

_____

_____

_____

Причина допуска сотрудника к работе в коллектив без своевременного флюорографического обследования_____

_____

Выводы, отражающие оценку состояния организации выявления туберкулеза в учреждении (с указанием границ «очага»)

_____

_____

_____

_____

Рекомендации руководителю учреждения:

1. Заказать и организовать проведение заключительной дезинфекции в «очаге» туберкулеза в срок (не позднее суток с момента получения заявки от ПТД и госпитализации больного)
2. Составить списочный состав всех контактных лиц, находящихся в очаге туберкулезной инфекции.
3. Провести первичное обследование контактных лиц в очаге туберкулеза в срок 14 дней с момента выявления больного (осмотр фтизиатра, диаскинтест, рентгенологическое обследование).
4. Обеспечить наблюдение за контактными лицами в очаге туберкулеза (с даты формирования очага до даты снятия с учета – 1 год) и их динамическое обследование 1 раз в 6 месяцев (диаскинтест, рентгенологическое обследование).
5. Обеспечить проведение профилактического лечения туберкулеза лицам в очаге туберкулеза под контролем фтизиатра.
6. Отстранить от посещения коллектив всех лиц, не прошедших профилактический осмотр на туберкулез в положенные сроки.
7. Обеспечить неотложное обследование у фтизиатра всех лиц, не прошедших профилактический осмотр на туберкулез в положенные сроки.

Участковый фтизиатр (ФИО) _____ подпись _____

Руководитель учреждения (ФИО) _____ подпись _____

МП

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

Памятка пациенту и родственникам по проведению текущей дезинфекции в очаге туберкулезной инфекции

1. По возможности больному выделяют комнату или её часть, отгороженную ширмой, индивидуальную кровать, предметы личной гигиены, посуду и постельное белье. В комнате больного ограничивают число предметов повседневного пользования, оставляют легко поддающиеся мытью, очистке и обеззараживанию. Кровать больного устанавливают на расстоянии 0,5 метра от стены и 1,5 метров от кроватей других членов семьи.
2. Мягкую мебель закрывают чехлами. При уборке помещения, где проживает больной, обеззараживании посуды, остатков пищи родственникам больного следует переодеваться в специально выделенную для этой цели одежду (халат, косынка, перчатки). При смене постельного белья необходимо надевать маску из 4 слоев марли. Спецодежду собирают в бак с плотно закрытой крышкой отдельно от белья членов семьи и обеззараживают. Квартиру больного ежедневно убирают ветошью, смоченной в мыльно-содовом или дезинфицирующем растворе, при открытых дверях и окнах. Предметы сантехники, дверные ручки обеззараживают двукратным протиранием дезинфицирующим раствором. Дезинфицирующий раствор выдается медицинской сестрой противотуберкулезного учреждения. Проветривание помещения осуществляют не менее 2 раз в сутки по 30 мин. Мягкую мебель регулярно чистят пылесосом.
3. После еды посуду больного, очищенную от остатков пищи, сначала обеззараживают погружением в вертикальном положении в один из дезинфицирующих растворов, а затем промывают в проточной воде. Дезинфекцию пищевых отходов можно осуществлять с помощью дезинфицирующих растворов. Для этого остатки пищи заливают дезинфицирующим средством в соотношении 1:5 на 2 ч.
4. Грязное белье больного собирают в специальный бак с плотно закрытой крышкой отдельно от белья членов семьи. Обеззараживание белья осуществляют путем замачивания в дезинфицирующем растворе (5 л на 1 кг сухого белья)
5. Предметы ухода за больным и уборочный инвентарь обеззараживают после каждого их использования дезинфицирующим средством. При наличии мокроты необходимо обеспечить ее сбор и обеззараживание. Для этого больной должен иметь 2 специальных контейнера для сбора мокроты. В один контейнер больной должен собирать мокроту, а другой, заполненный мокротой, обеззараживать. Для этого контейнер с мокротой подвергают кипячению в течение 15 мин в 2 % растворе соды или без соды в течение 30 мин. Дезинфекцию мокроты можно осуществлять и путем погружения контейнера с мокротой в дезинфицирующий раствор. Время

экспозиции колеблется от 2 до 12 ч в зависимости от используемого дезинфицирующего средства.

6. Помещение (стены, пол кроме паркетных, двери, мебель) в комнатах больных, в местах общего пользования ежедневно убирают ветошью смоченной 2% горячим мыльно-содовым раствором или дезинфицирующим с экспозицией 1 час. При проведении влажной уборки обращают внимание на места скопления пыли (плинтуса, карнизы, отопительные батарее и т.д.). Стены моют до высоты 1,5-2 метров. По окончании уборки помещение проветривают, просушивают, окрашенные поверхности протирают сухой ветошью.

7. Мягкую мебель закрывают чехлами. Чистят тщательно жесткими щетками увлажненными дезинфицирующими растворами или пылесосят с последующим замачиванием мешков для сбора пыли и хлопчатобумажных прокладок или 0,25% раствора «Белизна-3» на 2 часа.

8. Уборочную ветошь кипятят в 2% содовом растворе 15 минут с момента закипания или обеззараживают в 0,5% р-ре «Белизна-3» с экспозицией 1 час прополаскивают, сушат и хранят в сухом виде. Комнатные цветы протирают ветошью смоченной водой, затем ветошь дезинфицируют в одном из вышеперечисленных растворов.

9. Носильные вещи больного еженедельно проветривают и проглаживают горячим утюгом. Рекомендуется так же отпаривание одежды 1 раз в неделю.

Приложение 10
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 01.04.2022 № 99/22

ЖУРНАЛ
учета дезинфицирующих средств, выданных для проведения текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Филиал « »

Отделение _____

Начат с «____»_____ 20____г.

Окончен «____»_____ 20____г.

Дата выдачи ДС	Наименование ДС	Количество выданного ДС (мл/шт)	ФИО и подпись работника выдавшего ДС	ФИО и подпись лица получившего ДС	ФИО и подпись лица получившего инструкцию по применению ДС	ФИО и подпись работника, проводившего инструкцию по проведению текущей дезинфекции	ФИО и подпись лица, прослушавшего инструкцию по проведению текущей дезинфекции